HTA

Cifra diagnóstica de HTA (AHA/ACC)

HTA

Fármaco de elección en HTA con diabetes y proteinuria

HTA

Antihipertensivos seguros en el embarazo

HTA

¿Cuándo iniciar con 2 fármacos?

CRISIS HIPERTENSIVA

Urgencia vs emergencia hipertensiva

CRISIS HIPERTENSIVA

Meta de descenso en emergencia hipertensiva

CRISIS HIPERTENSIVA

Meta en disección aórtica

CRISIS HIPERTENSIVA

Fármaco que NO se recomienda en urgencia hipertensiva

RESPUESTA · HTA

IECA o ARA II.

RESPUESTA · HTA

≥ 130/80 mmHg confirmada en 2 visitas.

RESPUESTA · HTA

Si la TA está ≥ 20/10 mmHg por arriba de la meta.

RESPUESTA · HTA

Metildopa, labetalol y nifedipino.

RESPUESTA · CRISIS HIPERTENSIVA

No más de 25 % de la TA media en la primera hora.

RESPUESTA · CRISIS HIPERTENSIVA

Ambas ≥ 180/120; la emergencia tiene daño agudo a órgano blanco.

RESPUESTA · CRISIS HIPERTENSIVA

Nifedipino sublingual (hipotensión brusca).

RESPUESTA · CRISIS HIPERTENSIVA

TAS < 120 mmHg en 20 minutos, con betabloqueador primero.

ANGINA

Criterios de angina típica

ANGINA

Antianginoso de primera línea en angina estable

ANGINA

Estudio inicial no invasivo en angina estable

ANGINA

Fármacos que reducen eventos en cardiopatía isquémica

SICA SEST

Angina inestable vs IAM SEST

SICA SEST

Biomarcador de elección en SICA

SICA SEST

Doble antiagregación en SICA

SICA SEST

¿Se trombolisa el SICA SEST?

RESPUESTA · ANGINA

Betabloqueador.

RESPUESTA · ANGINA

Dolor retroesternal característico + desencadenado por esfuerzo + cede con reposo o nitratos.

RESPUESTA · ANGINA

Aspirina y estatina de alta intensidad.

RESPUESTA · ANGINA

Prueba de esfuerzo (si puede caminar y el ECG es interpretable).

RESPUESTA · SICA SEST

Troponina ultrasensible.

RESPUESTA · SICA SEST

Ambos sin elevación del ST; el IAM SEST tiene troponina elevada.

RESPUESTA · SICA SEST

No; la trombólisis solo está indicada en el SICA CEST.

RESPUESTA · SICA SEST

Aspirina + inhibidor P2Y12 (ticagrelor, prasugrel o clopidogrel).

SICA CEST

Reperfusión de elección en IAM CEST

SICA CEST

IAM inferior: derivaciones y arteria

SICA CEST

Manejo del infarto del ventrículo derecho

SICA CEST

Causa más frecuente de muerte temprana en el IAM

RIESGO CV

Estatinas de alta intensidad

RIESGO CV

Meta de LDL en prevención secundaria (muy alto riesgo)

RIESGO CV

LDL ≥ 190 mg/dL: conducta

RIESGO CV

Edad para calcular el riesgo a 10 años con escalas

RESPUESTA · SICA CEST

DII, DIII y aVF; coronaria derecha.

RESPUESTA · SICA CEST

Angioplastia primaria si se logra en < 120 min; si no, trombólisis.

RESPUESTA · SICA CEST

Arritmias ventriculares (fibrilación ventricular).

RESPUESTA · SICA CEST

Volumen IV; evitar nitratos, morfina y diuréticos.

RESPUESTA · RIESGO CV

< 55 mg/dL.

RESPUESTA · RIESGO CV

Atorvastatina 40–80 mg y rosuvastatina 20–40 mg.

RESPUESTA · RIESGO CV

40 a 75 años sin enfermedad CV establecida.

RESPUESTA · RIESGO CV

Estatina de alta intensidad sin necesidad de calcular el riesgo.

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

Causa más común de cardiopatía isquémica

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

Indicaciones clásicas de cirugía de revascularización

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

Pilares del tratamiento médico óptimo

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

Isquemia silente: grupo de riesgo

IC CRÓNICA

IC con FEVI reducida

IC CRÓNICA

Los 4 pilares de la IC con FEVI reducida

IC CRÓNICA

Estudio para medir la fracción de eyección

IC CRÓNICA

Clase NYHA III

RESPUESTA · CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

Tronco de la coronaria izquierda, 3 vasos, diabético multivaso.

RESPUESTA · CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

Aterosclerosis coronaria.

RESPUESTA · CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

Diabéticos y adultos mayores.

RESPUESTA · CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

Aspirina, estatina, betabloqueador y control de factores de riesgo.

RESPUESTA · IC CRÓNICA

ARNI/IECA/ARA II, betabloqueador, espironolactona e iSGLT2.

RESPUESTA · IC CRÓNICA

FEVI ≤ 40 %.

RESPUESTA · IC CRÓNICA

Síntomas con actividad menor a la habitual; cómodo en reposo.

RESPUESTA · IC CRÓNICA

Ecocardiograma transtorácico.

IC AGUDA

Perfil más común de IC aguda

IC AGUDA

Tratamiento del edema agudo pulmonar hipertensivo

IC AGUDA

Inotrópico en IC aguda con bajo gasto

IC AGUDA

Vasopresor de elección en choque cardiogénico

FIBRILACIÓN AURICULAR

ECG de la fibrilación auricular

FIBRILACIÓN AURICULAR

Escala para decidir anticoagulación en FA

FIBRILACIÓN AURICULAR

FA con inestabilidad hemodinámica

FIBRILACIÓN AURICULAR

Anticoagulante en FA con válvula mecánica

RESPUESTA · IC AGUDA

Oxígeno/VMNI, furosemida IV y nitroglicerina.

RESPUESTA · IC AGUDA

Caliente y húmedo (congestión con buena perfusión).

RESPUESTA · IC AGUDA

Norepinefrina.

RESPUESTA · IC AGUDA

Dobutamina.

RESPUESTA · FIBRILACIÓN AURICULAR

CHA_2DS_2-VASc.

RESPUESTA · FIBRILACIÓN AURICULAR

Ritmo irregularmente irregular, sin ondas P, ondas f.

RESPUESTA · FIBRILACIÓN AURICULAR

Warfarina (antagonista de vitamina K).

RESPUESTA · FIBRILACIÓN AURICULAR

Cardioversión eléctrica sincronizada inmediata.

TSV

Mecanismo más común de TSV

TSV

Primer paso en TSV estable

TSV

Fármaco de elección si fallan las maniobras

TSV

Tratamiento definitivo de la TSV recurrente

BLOQUEO AV

Bloqueo AV de primer grado

BLOQUEO AV

Mobitz I (Wenckebach)

BLOQUEO AV

Mobitz II

BLOQUEO AV

Primer fármaco en bradicardia sintomática

RESPUESTA · TSV

Maniobras vagales.

RESPUESTA · TSV

Reentrada en el nodo AV.

RESPUESTA · TSV

Ablación con catéter.

RESPUESTA · TSV

Adenosina IV en bolo rápido (6 mg, luego 12 mg).

RESPUESTA · BLOQUEO AV

PR que se alarga progresivamente hasta una P bloqueada.

RESPUESTA · BLOQUEO AV

PR > 200 ms constante; todas las P conducen.

RESPUESTA · BLOQUEO AV

Atropina.

RESPUESTA · BLOQUEO AV

PR constante con P que de pronto no conducen; requiere marcapasos.

WPW

Hallazgos ECG del WPW

WPW

Vía accesoria del WPW

WPW

Fármacos contraindicados en FA preexcitada

WPW

Tratamiento definitivo del WPW

ENDOCARDITIS

Agente más común de endocarditis en usuarios de drogas IV

ENDOCARDITIS

Criterios mayores de Duke

ENDOCARDITIS

Nódulos de Osler vs lesiones de Janeway

ENDOCARDITIS

Profilaxis dental en paciente de alto riesgo

RESPUESTA · WPW

Haz de Kent.

RESPUESTA · WPW

PR corto, onda delta y QRS ancho.

RESPUESTA · WPW

Ablación de la vía accesoria.

RESPUESTA · WPW

Bloqueadores del nodo AV: adenosina, verapamilo, digoxina, betabloqueadores.

RESPUESTA · ENDOCARDITIS

Hemocultivos positivos típicos y evidencia ecocardiográfica de afección endocárdica.

RESPUESTA · ENDOCARDITIS

Staphylococcus aureus (válvula tricúspide).

RESPUESTA · ENDOCARDITIS

Amoxicilina 2 g VO 30–60 min antes.

RESPUESTA · ENDOCARDITIS

Osler: dolorosos (inmunológicos). Janeway: indoloros (embólicos).

PERICARDITIS

ECG de la pericarditis aguda

PERICARDITIS

Tratamiento de la pericarditis aguda

PERICARDITIS

Tríada de Beck

PERICARDITIS

Tratamiento del taponamiento cardiaco

VALVULOPATÍA AÓRTICA

Tríada de la estenosis aórtica grave

VALVULOPATÍA AÓRTICA

Soplo de la estenosis aórtica

VALVULOPATÍA AÓRTICA

Soplo de la insuficiencia aórtica

VALVULOPATÍA AÓRTICA

Pulso típico de la insuficiencia aórtica

RESPUESTA · PERICARDITIS

AINE o aspirina + colchicina (3 meses).

RESPUESTA · PERICARDITIS

Elevación difusa y cóncava del ST con depresión del PR.

RESPUESTA · PERICARDITIS

Pericardiocentesis urgente.

RESPUESTA · PERICARDITIS

Hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardiacos apagados.

RESPUESTA · VALVULOPATÍA AÓRTICA

Sistólico expulsivo en foco aórtico, irradiado a carótidas.

RESPUESTA · VALVULOPATÍA AÓRTICA

Angina, síncope y disnea.

RESPUESTA · VALVULOPATÍA AÓRTICA

Pulso saltón (de Corrigan) con presión diferencial amplia.

RESPUESTA · VALVULOPATÍA AÓRTICA

Diastólico aspirativo en el borde esternal izquierdo.

VALVULOPATÍA MITRAL

Causa más común de estenosis mitral

VALVULOPATÍA MITRAL

Soplo de la estenosis mitral

VALVULOPATÍA MITRAL

Soplo de la insuficiencia mitral

VALVULOPATÍA MITRAL

Tratamiento de la estenosis mitral con válvula favorable

VALVULOPATÍA TRICUSPÍDEA

Causa más común de insuficiencia tricuspídea

VALVULOPATÍA TRICUSPÍDEA

Signo de Rivero-Carvallo

VALVULOPATÍA TRICUSPÍDEA

Onda del pulso yugular en insuficiencia tricuspídea

VALVULOPATÍA TRICUSPÍDEA

Endocarditis tricuspídea: grupo de riesgo

RESPUESTA · VALVULOPATÍA MITRAL

Diastólico en retumbo en el ápex con chasquido de apertura.

RESPUESTA · VALVULOPATÍA MITRAL

Fiebre reumática.

RESPUESTA · VALVULOPATÍA MITRAL

Valvuloplastia mitral percutánea con balón.

RESPUESTA · VALVULOPATÍA MITRAL

Holosistólico en el ápex irradiado a la axila.

RESPUESTA · VALVULOPATÍA TRICUSPÍDEA

El soplo tricuspídeo aumenta con la inspiración.

RESPUESTA · VALVULOPATÍA TRICUSPÍDEA

Funcional, por dilatación del VD.

RESPUESTA · VALVULOPATÍA TRICUSPÍDEA

Usuarios de drogas intravenosas.

RESPUESTA · VALVULOPATÍA TRICUSPÍDEA

Onda v gigante.

COARTACIÓN AÓRTICA

Signo radiográfico clásico de coartación

COARTACIÓN AÓRTICA

Síndrome genético asociado a coartación

COARTACIÓN AÓRTICA

Valvulopatía asociada a coartación

COARTACIÓN AÓRTICA

Hallazgo clínico clave

DISECCIÓN AÓRTICA

Factor de riesgo más importante de disección aórtica

DISECCIÓN AÓRTICA

Stanford A vs B

DISECCIÓN AÓRTICA

Estudio de elección en paciente estable

DISECCIÓN AÓRTICA

Primer fármaco en disección aórtica

RESPUESTA · COARTACIÓN AÓRTICA

Síndrome de Turner.

RESPUESTA · COARTACIÓN AÓRTICA

Muescas costales (Roesler) y signo del 3.

RESPUESTA · COARTACIÓN AÓRTICA

HTA en brazos con pulsos femorales débiles o retrasados.

RESPUESTA · COARTACIÓN AÓRTICA

Válvula aórtica bicúspide.

RESPUESTA · DISECCIÓN AÓRTICA

A: afecta la aorta ascendente (cirugía). B: solo descendente (médico).

RESPUESTA · DISECCIÓN AÓRTICA

Hipertensión arterial.

RESPUESTA · DISECCIÓN AÓRTICA

Betabloqueador IV (esmolol o labetalol).

RESPUESTA · DISECCIÓN AÓRTICA

Angiotomografía de aorta.